

Volver a la ficha del paciente

Nicolas Smoke

Inicial · CC 1040742568 · 13/7/2026

► Historial de correcciones (1)

Evaluación Diagnóstico Tratamiento Seguimiento **Reporte / HC**



PD

Nicolas Smoke

CC 1040742568 · 31/8/2026

Inicial

Aprobado

[Ver resultados](#) [Ver preview](#)

Modo de envio al paciente

- ☐ Reporte de Atlas
- ☐ Solo mis notas
- ☒ Reporte de Atlas y mis notas

Los modos con notas requieren que las hayas escrito al aprobar.

Enviar al paciente

Este reporte está aprobado y es inmutable. Sus notas quedaron congeladas al aprobar; para cambiar el contenido o las notas se genera una corrección (una versión nueva del reporte).

Historia clínica

🖨 Imprimir o guardar PDF

DATOS DEL PACIENTE

Paciente

Nicolas Smoke

Edad / Sexo

22a · Masculino

Peso / Talla

80.4 kg · 177 cm

Fecha

31/8/2026

Profesional

Profesional Demo

Ocupación

Empresario(a) / Emprendedor(a)**MOTIVO DE CONSULTA**

No se registró

ANTECEDENTES PERSONALES**DIAGNÓSTICOS PERSONALES**

Otra: rinitis cronica

HTA diagnosticada

No

Medicación antihipertensiva

No

Antecedentes familiares

Cáncer

Lactancia materna

Sí, 6 meses o más**MEDICAMENTOS ACTUALES**

Ninguno

ALERGIAS E INTOLERANCIAS

Alergias alimentarias

Ninguna

Intolerancias

Ninguna**EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES**

Contaminación del aire

RESUMEN DIAGNÓSTICO · NUTRICIONISTA

El paciente evidencia bajo consumo de verduras y hortalizas, frutas enteras, leguminosas, pescado y mariscos, grasas saludables (aguacate, aceite de oliva y frutos secos) y lácteos y fermentados, y consumo elevado de cereales refinados y harinas blancas; sus alimentos los

prepara un familiar; come fuera de casa 1 a 2 veces por semana; desayuna todos los días; cena entre las 8 y las 9 pm; no presenta inseguridad alimentaria; con acceso fácil a alimentos frescos y saludables; tiene un consumo insuficiente de líquidos (4 vasos de agua al día).

DIAGNÓSTICO FUNCIONAL INTEGRADO (DFI)

El paciente conserva una función celular óptima con riesgo celular bajo; en el dominio metabólico-estructural presenta susceptibilidad cardiometabólica baja con un fenotipo estructural de normal/normal; su envejecimiento biológico está acelerado (15 años por encima de lo esperado); en lo conductual-perceptual no hay distorsión de la imagen corporal; y la carga contextual y de estilo de vida es moderada. El perfil configura un riesgo integrado alto, que activa las siguientes rutas de atención: Ruta 4 (Desaceleración del Envejecimiento), prioritaria.

META TERAPÉUTICA

Meta de nutrición: asegurar proteína alta por sexo y un patrón antiinflamatorio para desacelerar el envejecimiento biológico. Meta a 24 semanas: reducción del IAE de al menos 2 años.

COMPOSICIÓN CORPORAL · ÍNDICES ALTERADOS

Composición corporal - Niveles de Wang

VARIABLE	VALOR	REFERENCIA	Δ	DIAGNÓSTICO
NIVEL V · CUERPO ENTERO				
IMC (kg/m²)	25,66	18,5–24,9	+0,76	Sobrepeso
NIVEL IV · TEJIDOS Y SISTEMAS				
Grasa corporal total - Lípidos Wang (%)	22,44	10–22%	+0,44	Sobrepeso adiposo
Fenotipo MCCB (FFMI×FMI)	Normopeso	—	—	Normopeso
NIVEL III · CELULAR				
Sólidos extracelulares - matriz colágena (kg)	5,24	7,06 *	-1,82	Déficit matriz — considerar colágeno
Extracelular/intracelular con grasa (E/I)	0,63	0,35–0,40	+0,23	Sobrecarga extracelular/inflamación
Extracelular/intracelular sin grasa (E/I)	0,57	0,35–0,40	+0,17	Sobrecarga extracelular/inflamación

VARIABLE	VALOR	REFERENCIA	Δ	DIAGNÓSTICO
NIVEL II · MOLECULAR				
Hidratación sin grasa - deshidratación (%)	70,33	≥73% (normohidrat.)	-2,67	Deshidratación leve
* Referencia poblacional en validación por la Dirección Científica (se deriva de peso, talla y sexo cuando el equipo no la trae). No significa que el dato esté mal: espera confirmación. IMC, cintura, índice cintura-cadera (ICC) e índice cintura-talla (ICT) usan umbrales de referencia médica estándar (OMS), no un resultado del motor ANI-BIS-E.				

ANI BIS-E

Hidro-Homeostasis IEHH	0.81	≤0.0 óptimo	Leve
Aceleración del Envejecimiento IAE	+14.7 a	-5 a +5 años	Acelerado
PABU	1.202	φ = 1,618 (k=0,78)	Desviación por exceso

Los valores son los de esta evaluación. Los rangos de referencia son los del modelo vigente hoy, no los del día de la consulta.

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO

Dieta anti-inflamatoria

TRATAMIENTO · PLAN NUTRICIONAL

GEB (Mifflin) 1872 kcal	GET 2574 kcal
Objetivo 2574 kcal/día	Proteínas 58 g/día (0.8 g/kg)
Carbohidratos 393 g/día	Grasas 86 g/día
Sodio Pendiente	Actividad física FA ligera

El límite de sodio se emitirá cuando se incorpore el motor de prescripción nutricional. No es que este paciente no lo tenga: todavía no se calcula.

RECOMENDACIONES

Alimentación saludable general

- Hidratación de 30 a 35 mL/kg/día
- Frutas y verduras de varios colores en cada comida
- Preparaciones al vapor, al horno o a la plancha
- Planificar las compras según el plan
- Leer etiquetas (grasa saturada, azúcar, sodio)
- Distribuir las comidas cada 3 a 4 horas

REMISIONES Y DERIVACIONES

No se registraron remisiones ni derivaciones en esta consulta.

RUTAS DE INTERVENCIÓN ACTIVADAS

R4 — Desaceleración del Envejecimiento

Indicador: IAE acelerado + Sarcopenia / FFMI bajo clasificado

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL

Estas son las notas de tratamiento

1/9/2026, 5:52:07 p. m.

PRÓXIMA CONSULTA

30/10/2026

AUTORIZACIONES BAJO LAS QUE SE RECOGIÓ ESTA INFORMACIÓN

Consulta capturada bajo el consentimiento **versión 1.0**.

Autorización	Estado	Versión	Fecha
Finalidades del servicio (necesaria)	Vigente	1.0	31/8/2026
Datos sensibles de salud (necesaria)	Vigente	1.0	31/8/2026
Investigación científica	Vigente	1.0	31/8/2026
Continuidad asistencial	Vigente	1.0	31/8/2026
Publicidad	Vigente	1.0	31/8/2026

FIRMA Y FECHA

Profesional Demo

31/8/2026

Cerrar la consulta

Marca esta consulta como terminada. Esto no sella nada de lo clínico: el diagnóstico, el tratamiento y el reporte conservan su propio estado.

Antes de cerrar, esto quedó sin hacer

El tratamiento no se aprobó

El plan queda como borrador y no se sella.

[Ir a resolverlo](#)

El reporte está aprobado pero no se envió

El paciente todavía no lo recibió.

[Ir a resolverlo](#)

No se registró la decisión sobre los nutracéuticos

Se pregunta siempre, aunque la respuesta sea que no los lleva.

[Ir a resolverlo](#)

Puedes cerrarla igual: cerrar con algo pendiente es una decisión tuya, y queda registrada.

Cerrar la consulta